

個別症例安全性報告

報告ID：ICSR-2025-004

報告種別：自発報告・消費者報告（家族）

報告日：2025-12-10

報告者：患者の夫（配偶者）

報告者資格：非医療従事者

発生国：日本

MedDRAバージョン：27.0

注記：本報告は製造販売業者の消費者向けホットラインを通じて受信された。報告者は患者の配偶者である。報告者が述べた表現はそのまま保持しており、企業安全性担当医師が報告者の記述に基づいてMedDRA基本語（PT）コードを割り当てた。

患者情報

患者イニシャル：Y.K.

年齢：42歳

性別：女性

体重：報告なし

既往歴（配偶者からの報告）：

- うつ病、約6年前に診断
- 「たまに寝つきが悪いことはあるけど、大したことはない」
- 配偶者が把握している範囲では既知のアレルギーなし

被疑薬

薬剤名：DrugA

適応：大うつ病性障害

用法・用量：25 mgを1日1回、1週間投与後、処方精神科医により50 mgを1日1回へ増量

投与経路：経口

投与開始日：2025-10-20

投与終了日：報告時点で継続中

薬剤に対して取られた処置：なし（精神科医の管理下で患者は投薬を継続中）

併用薬

- 以前に処方された睡眠のための薬。「本当に眠れないときにたまに飲む」程度（薬剤名は報告者には不明）
- マルチビタミン、毎日

報告者が記述した有害事象（ADVERSE EVENTS AS DESCRIBED BY REPORTER）

以下の事象は、報告者が一般人の言葉（lay language）で記述したものである。企業の安全性審査によりMedDRA基本語（PT）を割り当てた。

報告者の記述：「とにかくずっと疲れてるんですよ。いくら寝ても抜けないっていうか。前も、うつのせいで疲れることはあったんですけど、今回ののはなんか違うみたいで。本人が言うには、気持ちが落ち込んで疲れるっていうより、体がずっしり重い感じの疲れなんだそうです。」

割り当てMedDRA PT：疲労（Fatigue）

発現：DrugA開始から約5日後

転帰：継続中

重篤性：非重篤

報告者の記述：「もう全然寝つけないんです。くたくたなのに、ただ横になってるだけで。で、やっと寝

ついたと思ったら、夜中の3時とか4時に目が覚めちゃって、そのまま眠れなくなる。それが毎晩なんですよ、本当に毎晩。」

割り当てMedDRA PT：不眠症（Insomnia）

発現：DrugA開始から約1週間後

転帰：継続中

重篤性：非重篤

報告者の記述：「お腹の調子も良かったり悪かったりで。トイレに何回も駆け込む日もあれば、吐き気がして何も食べたくないっていう日もあって。ずっとってわけじゃないんですけど、本人はけっこう参ります。」

割り当てMedDRA PT（事象A）：下痢（Diarrhoea）

割り当てMedDRA PT（事象B）：悪心（Nausea）

発現：DrugA開始から約10日後

転帰：間欠的、継続中

重篤性：非重篤

報告者の記述：「これが一番心配なんですけど、手とか足に変な感じがするらしくて。なんかビリビリするっていうか、小さい虫が肌を這ってるみたいな感じだって。ときどきビリビリしびれる感じのときもあれば、感覚が鈍い感じのときもあるみたいで。出たり消えたりするんです。痛いわけじゃないけど、とにかく気持ち悪いっていうか、なんか落ち着かないって言ってます。」

割り当てMedDRA PT：錯感覚（Paraesthesia）

発現：DrugA開始から約2週間後、50 mgへの増量後により顕著

転帰：継続中

重篤性：非重篤

報告者の記述：「前は好きだったことにも、まったく興味を示さなくなっちゃって。ガーデニングが大好きだったのに、今はもう外にも出たがらないんです。それがうつの一部だっていうのは分かってるんですけど、先生は、薬はむしろそういうのを良くしてくれるはずだって言ってたのに、逆に悪くなってる気がして。薬が本来と逆の働きをしてるんじゃないかって、そこが心配なんです。」

割り当てMedDRA PT：快感消失（Anhedonia）

割り当てMedDRA PT（関連）：うつ病悪化（Depression worsened）

発現：DrugA開始から約3週間後

転帰：継続中

重篤性：非重篤（治療担当精神科医による経過観察下）

因果関係評価

報告者による因果関係：評価なし（消費者報告）

企業による因果関係（企業安全性担当医師による評価）：全事象について「可能性あり（Possible）」。

WHO-UMC判定：可能性あり（Possible）。時間的関連性は矛盾しないが、患者は投薬を継続しており、投与中止（dechallenge）は実施されていない。一部の事象（不眠症、錯感覚、消化器症状）は、本薬効群に関連して知られている副作用である。基礎疾患であるうつ病の悪化については、現時点では、治療効果不十分によるものか、薬剤起因性の作用によるものかを確実に区別することができない。

症例経過

患者は42歳の女性で、6年間の大うつ病性障害の既往を有する。2025-10-20に治療担当精神科医よりDrugAが処方され、25 mgを1日1回で開始し、忍容性に問題がなければ1週間後に50 mgを1日1回へ増量する予定であった。50 mgへの増量は2025-10-27頃に行われた。

製造販売業者のホットラインへの報告は、2025-12-10に患者の夫によってなされた。夫は、新しい薬を飲み始めてから妻の「様子が違う」と述べた。夫は、徐々に発現し、薬剤との関連を懸念している一連の

症状について説明した。夫は、自分が説明している症状の一部は妻の基礎疾患であるうつ病の一部である可能性があることを認めたうえで、投薬開始と症状発現との時間的關係、および症状がこれまでのうつ病の経験とは質的に異なると妻自身が述べていることから、電話するに至ったと述べた。

本報告のために患者本人への直接の聞き取りは行われていない。企業安全性担当医師は、患者の口頭同意を得たうえで、2025-12-12に治療担当精神科医に連絡した。精神科医は、直近の2025-12-05の受診時に患者が同様の症状を報告していたこと、および2週間後の再診を予定して厳重な観察下で投薬を継続していることを確認した。精神科医は、時間的関連性および症状のプロファイルがDrugAによる有害事象の可能性と矛盾しないことに同意したが、抗うつ薬療法を早期に中止することにはそれ自体の臨床的リスクが伴うことを強調した。

患者は本報告時点でDrugAの服用を継続している。追跡調査が予定されている。

報告者の逐語的引用は添付ノートに保存

消費者向けホットライン通話の全記録は症例ファイルに保存されている。報告者の主要な引用は、記述の元来の特徴を保持し、その後のMedDRAコーディング審査を支援するために、上記に再掲した。

追跡調査

患者の次回受診予定日である2025-12-19の後に、治療担当精神科医との追跡調査を予定している。